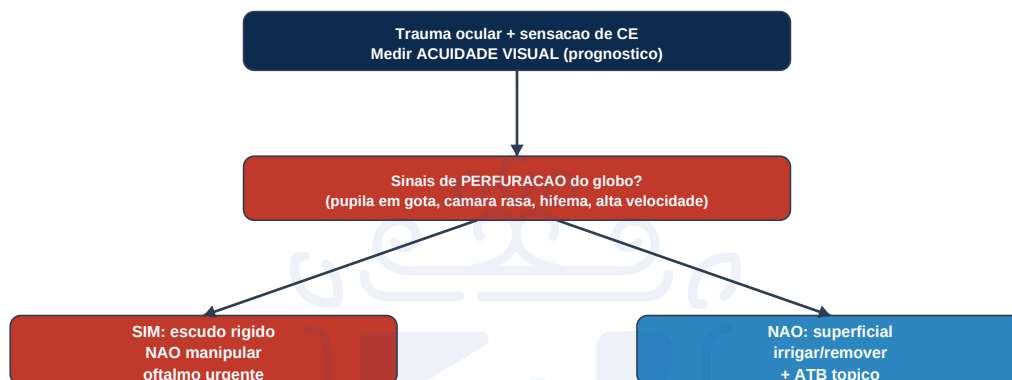


CORPO ESTRANHO OCULAR — EXCLUIR PERFURAÇÃO

FLUXOGRAMA — ABORDAGEM

CORPO ESTRANHO — SUPERFICIAL OU PERFURANTE?



DEFINIÇÃO E CLASSIFICAÇÃO

O QUE É

- Material que penetra/aloja nas estruturas oculares ou anexos por trauma mecânico
- Externo (superfície: córnea, conjuntiva, pálpebra) | Intraocular | Intraorbitário
- Material: metálico (maioria dos CE intraoculares), orgânico (madeira/planta — alto risco infeccioso), vidro/plástico
- Mecanismo: baixa velocidade (poeira/cílio, superficial) x ALTA velocidade (esmeril, martelo — risco de perfuração)

PERGUNTAS-CHAVE

ANAMNESE DIRIGIDA

- Como ocorreu? Estava martelando/lixando/cortando? Impacto de alta energia ou projétil?
- Há quanto tempo? (apresentação > 24h aumenta risco de endoftalmite)
- Qual material? (orgânico = maior risco infeccioso)
- Dor, baixa de visão, fotofobia, flashes ou moscas volantes?
- Usava EPI? Usa lente de contato? Tentou remover/esfregou o olho?

EXAME FÍSICO

AValiação Sistemática

- ACUIDADE VISUAL (obrigatória, cada olho separado) — principal fator prognóstico; documentar antes de manipular
- Inspeção: pálpebras, conjuntiva, córnea (fluoresceína), câmara anterior (profundidade, hifema, hipópio)
- Pupila: formato (irregular/em gota sugere perfuração), reflexo, DPAR
- EVERSÃO DA PÁLPEBRA SUPERIOR: fundamental para CE subtarsal (olhar para baixo, everter com cotonete)
- Motilidade ocular (restrição = lesão muscular/orbitária); fundoscopia se possível

RED FLAGS — PERFURAÇÃO DO GLOBO

SINAIS DE GLOBO ABERTO

- Diminuição acentuada da acuidade visual
- Pupila irregular ou em 'gota'; câmara anterior rasa ou ausente
- Hifema (sangue) ou hipópio (pus); prolapso de íris/conteúdo intraocular
- Ferida penetrante visível; hemorragia subconjuntival extensa circunferencial
- Mecanismo de alta velocidade (martelo/esmeril) MESMO com exame inicial normal

CONDUTA — POR CENÁRIO

Rx SUSPEITA DE PERFURAÇÃO

NÃO manipular, NÃO pressionar, NÃO instilar colírios/pomadas
Proteger com ESCUDO RÍGIDO (nunca curativo compressivo)
Jejum (cirurgia iminente); evitar Valsalva
ATB sistêmico profilático + antiemético + analgesia (evitar AINE)
Profilaxia antitetânica; oftalmo de URGÊNCIA

Rx CE SUPERFICIAL (sem alarme)

Remover por irrigação com SF; anestésico tópico apenas para o exame
Se não sair com irrigação -> encaminhar para remoção com lâmpada de fenda
Pós-remoção: Tobramicina 0,3% 4/4h por 5 dias
AINE tópico (diclofenaco 0,1% 6/6h) + lágrimas artificiais
Analgesia oral; não usar lente de contato 5-7 dias

ESTRATIFICAÇÃO DO ENCAMINHAMENTO

Urgência	Situações	Conduta
Imediato (< 24h)	Perfuração/CE intraocular, DPAR, hifema, CE orgânico, alta velocidade, endoftalmite	Oftalmo URGENTE; escudo
24-48h	CE superficial removido com abrasão extensa, sintomas persistentes, usuário de lente	Reavaliação oftalmológica
Manejo no PS	CE superficial removível por irrigação, abrasão simples, AV preservada	Alta com prescrição e retorno

CHECKLIST / ORIENTAÇÕES PÓS-REMOÇÃO

ALTA SEGURA

- ☐ Acuidade visual preservada e sem sinais de alarme
- ☐ Córnea sem opacidade densa/úlceras; câmara anterior normal
- ☐ NÃO esfregar o olho; NÃO usar lente de contato até cicatrizar (5-7 dias); não tampar globo aberto
- ☐ Lavar as mãos antes dos colírios; óculos escuros se fotofobia
- ☐ Retorno IMEDIATO se: piora da dor, baixa de visão, vermelhidão intensa, secreção purulenta ou sem melhora em 24-48h

MODELO DE ENCAMINHAMENTO — OFTALMO

RESUMO PARA REGULAÇÃO

- Trauma ocular em OD/OE há ____ h; mecanismo: ____ (metal-metal/esmeril/vegetal/poeira). EPI: sim/não.
- AV: OD ____ / OE _____. Localização do CE: conjuntiva/córnea/suspeita intraocular.
- Conduta: irrigação / tentativa de remoção sem sucesso / escudo rígido (se suspeita de perfuração) / analgesia.
- Solicito avaliação especializada para remoção sob lâmpada de fenda e exclusão de CE retido/ceratite.



SM24
Suporte ao Plantão Médico

FIXAÇÃO — QUESTÕES DE RESIDÊNCIA

QUESTÃO 1

USP-SP / Adaptada

Paciente estava martelando metal e refere baixa de visão súbita, pupila em 'gota' e câmara anterior rasa. Conduta correta?

- A) Irrigar abundantemente e remover o corpo estranho na unidade
- B) Instilar colírio antibiótico e pomada e dar alta
- C) Proteger com escudo rígido, NÃO manipular, iniciar ATB sistêmico e encaminhar com urgência (suspeita de globo aberto)
- D) Aplicar curativo compressivo no olho
- E) Prescrever AINE tópico e reavaliar em 48h

QUESTÃO 2

AMRIGS / Adaptada

Qual é o principal fator prognóstico a ser documentado no trauma/corpo estranho ocular?

- A) Pressão arterial
- B) Acuidade visual inicial
- C) Tipo de secreção
- D) Idade do paciente
- E) Tempo de jejum

QUESTÃO 3

SES-DF / Adaptada

Paciente com sensação de corpo estranho persistente, mas córnea sem alterações visíveis. Qual manobra é fundamental?

- A) Tonometria de imediato
- B) Eversão da pálpebra superior para procurar corpo estranho subtarsal
- C) Fundoscopia sob midríase
- D) Gonioscopia
- E) Lavagem com soro hipertônico

QUESTÃO 4

UNIFESP / Adaptada

Sobre o corpo estranho de material ORGÂNICO (madeira/vegetal), é correto:

- A) Tem baixo risco e pode ser observado em casa
- B) Tem maior risco infeccioso e merece encaminhamento/avaliação especializada
- C) Deve ser removido sempre com ímã
- D) Não causa endoftalmite
- E) Dispensa antibiótico

QUESTÃO 5

UFRJ / Adaptada

Corpo estranho corneano superficial removido por irrigação, AV preservada, sem sinais de alarme. Prescrição de alta adequada?

- A) Corticoide tópico em dose alta
- B) Antibiótico tópico (tobramicina) + lágrimas artificiais + analgesia, com orientação de retorno
- C) Curativo compressivo por 7 dias
- D) Apenas observação sem medicação
- E) Atropina sistêmica

GABARITO COMENTADO

QUESTÃO 1 → Resposta: C

Mecanismo de alta velocidade (martelo/metal) + pupila em gota + câmara rasa = globo aberto. NÃO manipular, NÃO pressionar, NÃO instilar colírios; proteger com escudo rígido, ATB sistêmico, antitetânica e oftalmo urgente.

QUESTÃO 2 → Resposta: B

A acuidade visual inicial é o principal fator prognóstico no trauma ocular e deve ser documentada antes de qualquer manipulação, em cada olho separadamente.

QUESTÃO 3 → Resposta: B

Na sensação persistente de corpo estranho com córnea aparentemente normal, a eversão da pálpebra superior é fundamental para localizar um CE subtarsal, causa frequente de abrasões lineares.

QUESTÃO 4 → Resposta: B

Corpos estranhos orgânicos (madeira/vegetal) têm maior risco infeccioso (inclusive fúngico) e de endoftalmite, exigindo avaliação especializada e cobertura adequada — não devem ser apenas observados.

QUESTÃO 5 → Resposta: B

Após remoção de CE superficial sem alarme, a prescrição é antibiótico tópico (tobramicina) + lágrimas artificiais + analgesia oral, com orientação de não esfregar/usar lente e retorno se piora.

SM24
Suporte ao Plantão Médico